MATERNA-AI — LEMBAR RESUME SKRINING PREEKLAMSIA & SURAT RUJUKAN KLINIS

ision Support System (POGI / PNPK Compliant) | Mode: Mode Tier 2 — Dokter RSUD Rujukan (Full Biomarker) | Model: Engine Tier 2 (Naive Ba

```
ID Rekam Medis (Anonim) : MAT-CLI-TIER2-002
Asal Faskes Pengirim    : FKTP / Puskesmas
Usia Ibu / Usia Gestasi : 36 Tahun  /  29 Minggu
Status Obstetrik        : G1P0  |  Nullipara: Ya (Primigravida/Nullipara)
Waktu Cetak Penapisan   : 2026-10-31 01:52 WIB
```

PROBABILITAS RISIKO: 100.0%

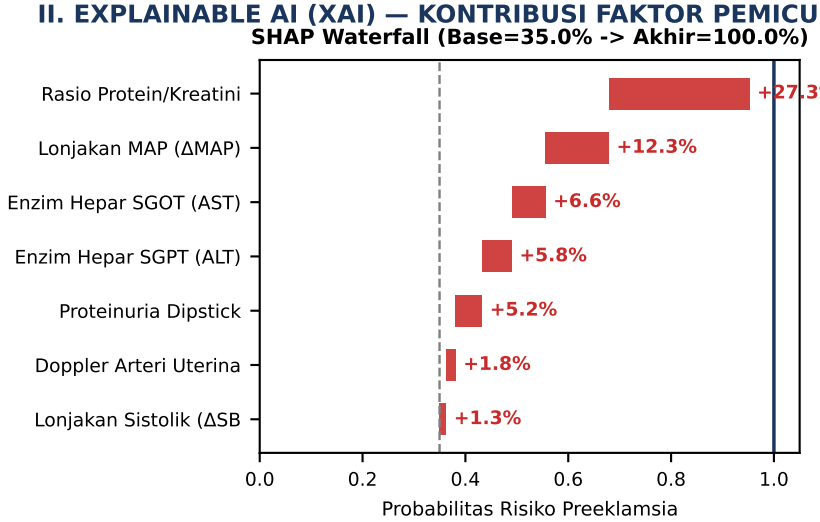
RISIKO TINGGI (> 40%)

Early-Onset Preeclampsia (< 34 Minggu) — Risiko Kritis Maternal-Fetal

I. PROFIL HEMODINAMIK LONGITUDINAL ANC, ANTROPOMETRI, & BIOMARKER ORGAN TARGET

ameter Klinis & Trajec	Nilai Pasien	Nilai Rujukan	Biomarker Tier 2	Nilai Lab	Rujukan Lab
Tekanan Darah Saat Ir	154/98 mmHg	Cutoff < 140/90 mmH	Proteinuria / PCR Urin	+2 (0.62 mg/mg)	Normal: Neg / <0.30
Mean Arterial Pressure	116.67 mmHg	Waspada >= 95 mmH	Hitung Trombosit	138 x10³/µL	Normal >= 150 x10³/µL
TD Trimester 1 & Delt	124/78 | ΔMAP +23.3	Waspada ΔMAP >= +	Kreatinin & Asam Urat	1.15 & 6.7 mg/dL	Kreat <1.1 | AU <5.5
Laju Kenaikan BB Ming	0.88 kg/minggu	Waspada >= 0.75 kg/	Enzim Hepar SGOT/SG	58 / 52 U/L	Normal < 40 U/L
IMT Pra-Hamil & LILA	29.4 kg/m² | 29.8 cm	IMT 18.5-24.9 kg/m²	Doppler Arteri Uterina	UtAPI = 1.58	Normal < 1.25 - 1.40

II. EXPLAINABLE AI (XAI) — KONTRIBUSI FAKTOR PEMICU RISIKO KUANTITATIF (SHAP & LIME)



Faktor Pemicu & Protektif Utama (XAI):
• +27.3% risiko karena Rasio Protein/Kreatinin Urin tinggi (0.62 mg/mg >= 0.3 mg/mg)
• +12.3% risiko karena Lonjakan MAP (ΔMAP) tinggi (23.34 mmHg >= 12.0 mmHg)
• +6.6% risiko karena Enzim Hepar SGOT (AST) tinggi (58 U/L >= 40 U/L)
• +5.8% risiko karena Enzim Hepar SGPT (ALT) tinggi (52 U/L >= 40 U/L)
• +5.2% risiko karena Proteinuria Dipstick positif (+2)

III. REKOMENDASI PROTOKOL KLINIS POGI / PNPK & LEMBAR RUJUKAN FASILITAS KESEHATAN

Urgensi Penanganan : SEGERA / EMERGENSI OBSTETRI (Rujukan Vertikal dalam < 24 Jam)
Tujuan Rujukan : RSUD Rujukan PONEK / Poliklinik Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG)
Temuan Red Flags : Hipertensi Gestasional / Preeklamsia (TD 154/98 mmHg >= 140/90 mmHg); Mean Arterial Pressure Kritis (MAP 116.7

Rekomendasi Tata Laksana Medis & Obstetrik (Sesuai PNPK POGI):
1. Protokol rujukan segera ke Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) di RSUD / Fasilitas PONEK.
2. Lakukan skrining USG Doppler Arteri Uterina (UtAPI), biometri janin, dan pemantauan kesejahteraan janin (NST/CTG).
3. Evaluasi panel laboratorium organ target lengkap (rasio protein/kreatinin urin, trombosit, SGOT/SGPT, kreatinin serum, LDH).
4. Pertimbangkan pemberian antihipertensi lini pertama (Nifedipin lepas lambat / Metildopa) jika TD >= 140/90 mmHg dan profilaksis MgSO4 bila terdapat gejala preeklamsia berat.

Catatan: Dokumen ini dihasilkan secara otomatis oleh Sistem Pendukung Keputusan Klinis MATERNA-AI. Keputusan medis definitif tetap berada pada otoritas klinis Dokter / Bidan penanggung jawab pasien.

Petugas Pemeriksa / Perujuk,

(Bidan / Dokter Pemeriksa FKTP/RS)